# REPORT

# 방학실습 과제물

한의약 정책 개발의 실제

2026학년도 여름방학


우석대학교 한의학과

120210731 박준영

# Ⅰ. 서론: 주제 선정 및 배경

## 1. 주제 선정

해당 과제는 보건복지부의 '제5차 한의약 육성발전 종합계획' 중 [목표 3-전략 2-③] '해외환자 유치 및 글로벌 진출 기반 조성'을 성공적으로 달성하기 위한 구체적인 정책 방안이다.

이를 위해 방한 외국인 환자의 수요가 집중된 미용·성형(K-뷰티) 시장에 한의학이 편승하여 시너지를 창출하는 전략이 핵심적인 방법이라고 생각한다. 이는 한국한의학연구원에 방문하였을 때 최병희 팀장님이 언급한 바와 같이, 이미 확고하게 구축된 미용 의료 시장이라는 '거인의 어깨에 올라타는' 접근법이다.

## 2. 국내외 관련 정책 추진 배경 및 현황

1) 현황: 미용·성형(K-뷰티)에 집중된 방한 의료관광 수요

2025년 우리나라를 방문한 외국인 환자 수는 201만 1,822명으로 사상 최초로 200만 명을 돌파했다. 진료 과목별 실적을 분석한 결과, 피부과 환자가 131만 2,700명(62.9%), 성형외과 환자가 23만 3,100명(11.2%)을 기록하며 전체 외국인 환자의 74.1%가 미용 의료 분야에 집중된 것으로 나타났다. 반면, 한방통합 진료를 이용한 외국인 환자는 3만 7,087명(1.8%)에 그쳐 진료 과목 간 수요의 뚜렷한 불균형이 확인되었다.[1)]

2) 추진 배경: 한의약 단독 유치의 한계와 편승 전략의 필요성

위 통계에서 볼 수 있듯, 한의학 단독 진료 모델만으로 대규모 해외 환자를 유치하는 기존의 접근 방식은 해외 인지도 및 실수요 측면에서 한계가 있다. 따라서 외국인 환자의 유입이 활발한 의과의 미용과 성형 인프라에 한의약이 자연스럽게 함께하는 편승 전략이 현시점에서 가장 효율적이고 현실적인 대안이다.

거대한 수요를 이미 확보한 K-뷰티 시장에 한의약 고유의 치료적 장점을 살린 사후관리 모델을 접목한다면, 외국인 환자가 느끼는 한의약에 대한 심리적 진입 장벽을 낮추고 성공적인 글로벌 진출의 기반을 확고히 다질 수 있을 것이다.

# Ⅱ. 본론 1: 의과 정책 현황 및 사각지대

## 1. 의과관련 정책 추진 현황

현재 정부는 외국인 환자 유치를 확대하기 위해 의과, 특히 미용과 성형 분야에 다양한 정책적 지원을 집중하고 있다. 대표적으로 외국인 미용과 성형 시술에 대한 부가가치세 환급 특례 제도를 들 수 있다.[2] 이 제도는 방한 외국인 관광객이 성형외과나 피부과에서 미용 목적의 시술을 받을 경우 부가가치세를 환급해 주는 것으로, 가격 경쟁력을 높여 K-뷰티 의료 시장의 양적 성장을 도왔다.[3]

또한, 메디컬코리아 지원센터를 통한 의료 정보 제공 및 홍보 지원 창구를 운영하고, 다국어 지원이 가능한 유치 플랫폼을 활성화하여 외국인 환자의 접근성을 크게 개선했다. 이러한 제도적 지원에 힘입어, 방한 외국인 환자의 압도적 다수가 피부과와 성형외과 진료에 집중되는 결과를 낳았다.[4]

## 2. 문제점 및 사각지대: 사후관리 인프라 부족

그러나 현재의 양방 미용과 성형의 진료 시스템은 수술 및 시술 자체의 성공에만 초점이 맞추어져 있다는 명확한 한계가 있다. 성형 수술 후에는 조직 손상으로 인해 필연적으로 심한 부종과 통증이 발생하며, 국소 부위의 미세혈류 순환 장애가 발생한다.[5]

문제는 이러한 수술 후유증을 관리하고 환자의 빠른 일상 복귀를 돕는 체계적인 사후관리 인프라가 양방 의원급 시장 내에는 부족하다는 점이다. 수술 부위의 단순 소독이나 항생제, 진통제 처방 등 대증적인 처치에 머물러 있어, 환자의 전인적 회복을 돕는 웰니스 트렌드와 자발적 건강관리 수요를 온전히 충족시키지 못하고 있다.

결과적으로 미용과 성형 수술 후 발생하는 부종을 효과적으로 치료하고 회복을 촉진하는 전담 의료 서비스의 부재는 외국인 환자의 종합적인 만족도를 떨어뜨리고, 더 나아가서는 K-뷰티 의료관광의 퀄리티의 저하를 초래할 수 있는 부분이다.

## Ⅲ. 본론 2: 한의약 정책 추진안

### 1. 해법1: 의원급 한·양방 교차고용 활성화 기반 마련

현재 정부는 의·한 협진 본사업 전환을 위해 병원급에서 검증된 협진 표준임상경로를 의원급 맞춤형으로 재설계하는 '중소지역 기반 의원급 진료 협진 모델' 개발을 추진하고 있다.[6] 방한 외국인 환자의 미용과 성형 진료가 주로 의원급 의료기관에 집중되어 있다는 점을 고려할 때, 이러한 의원급 협진 모델을 K-뷰티 시장에 적극적으로 접목해야 한다.

이를 실현하기 위한 가장 현실적인 방안은 성형외과 의원 내 한의사 고용, 혹은 한의원 내 의사 고용을 허용하고 장려하는 '의원급 한·양방 교차고용' 활성화이다. 최근 임상 현장에서는 한의사의 레이저 기기 등을 활용한 미용 시술 참여가 활발하게 이루어지고 있다.[7] 따라서 이 교차고용 모델은 한의사가 미용 시술에 직접 참여함과 동시에 체계적인 사후관리를 병행함으로써, 외국인 환자가 장소 이동 없이 수술부터 미용 시술, 회복에 이르는 전 과정을 제공받는 진정한 의미의 원스톱 융합 진료 환경을 구축하는 것이다.

### 기대효과: 미용 시장 보상 체계 안정화를 통한 필수의료 인력 쏠림 현상 완화

위와 같은 미용과 성형 시장 내 한·양방 교차고용은 현재 국가적 과제로 대두된 필수의료 인력 부족 문제를 간접적으로 완화하는 효과도 기대할 수 있다. 현재 의과 인력(gp)이 수련을 선택하는 대신 미용 시장으로 과도하게 유출되는 주요 원인 중 하나는 해당 분야의 높은 기대수익이다. 미용 의료 시장에 한의사 인력이 본격적으로 진입하여 공급이 확대되고 서비스 경쟁이 촉진되면, 미용 시장의 과도한 보상 체계가 점진적으로 안정화될 수 있다. 이는 궁극적으로 의과 인력의 미용 시장 쏠림 현상을 완화하고, 정부가 추진 중인 필수의료 분야로의 인력 재배치 및 유도 정책과도 시너지를 낼 수 있다.

### 한계점: 직역 단체의 갈등 및 1차 의료 생태계 위협 우려

이러한 의원급 교차고용 모델은 양 직역 단체(대한의사협회, 대한한의사협회 등)의 거센 반대에 부딪힐 가능성이 높다는 한계가 있다. 특히 한의계 내부에서는 자본력과 인프라가 거대한 성형외과 등 대형 피부 및 미용 의원으로 한의사가 종속되거나 흡수될 수 있다는 강한 우려가 있을 수 있다. 이는 K-뷰티 산업으로의 지나친 쏠림 현상을 유발하여, 결과적으로 지역 사회에서 1차 의료를 담당해 온 동네 한의원들의 경쟁력 약화와 생존권 위협으로 이어질 수 있다. 장기적으로는 기존 한의 의료 생태계가 말살될 수 있다는 내부의 반발을 어떻게 설득할 것인지가 주요 과제이다.

## 2. 해법 2: K-Recovery 패키지 상품화

성형 수술 후 필연적으로 발생하는 어혈과 부종, 통증을 신속하게 제어하기 위해 한의약 특화 'K-Recovery 패키지'를 상품화해야 한다. 구체적으로는 미세혈류 순환을 촉진하고 어혈을 제거하는 당귀수산 등의 한약 처방을 1차적으로 투여한다.[8] 이와 함께 안면 표정근과 진피층에 미세한 자극을 가해 국소 혈류 및 림프 순환을 촉진하고, 자발적인 콜라겐 합성을 유도하여 조직 재생과 안면부 부종 감소에 탁월한 효과를 보이는 정안침(미소안면침) 시술을 병행한다.[9] 더불어 수술로 인한 조직 손상 부위에 iNOS 및 COX-2 등 염증 매개 물질의 발현을 직접적으로 억제하여 강력한 국소 항염증 및 진통·부종 억제 효과를 발휘하는 황련해독탕 및 중성어혈 약침 시술을 결합함으로써[10], 외국인 환자의 회복 시간을 단축하는 진료 프로그램을 구성한다.

나아가 방한 외국인들이 주로 이용하는 미용 의료 플랫폼 및 다국어 유치 플랫폼 내에 '한의약 사후관리' 카테고리를 공식적으로 신설한다. 더불어 초기 수요 진작과 홍보를 위해 해당 패키지를 이용하는 외국인 환자를 대상으로 'K-Recovery 홍보 바우처'를 정부 및 지자체 차원에서 지원하여, 외국인 환자가 느끼는 심리적, 경제적 진입 장벽을 낮추고 한의약 사후관리 시장의 초기 안착을 유도해야 한다.

## 기대효과

1. K-뷰티 의료관광의 독보적 차별화 및 프리미엄 브랜드화

현재 태국, 중국 등 신흥 의료관광 국가들의 추격이 거센 가운데, 한국 미용 의료만의 새로운 경쟁 우위가 필요한 시점이다. 우수한 수술 기술에 한의약을 활용한 사후관리가 결합된 모델은 한국만의 독보적인 뷰티 의료의 차별점이 될 수 있다. 이는 K-뷰티를 단순한 미용 수술을 넘어 건강한 회복까지 책임지는 프리미엄 브랜드로 격상시키는 핵심 차별점이 될 것이다.

2. 외국인 환자의 다운타임 최소화 및 만족도 극대화

의료관광을 목적으로 방한한 외국인 환자들은 체류 기간이 제한적이기 때문에, 수술 후 회복 기간(다운타임)을 단축하는 것이 매우 중요하다. 한의약 기반의 부종 및 어혈 제어 프로그램은 환자의 일상 복귀를 앞당겨, 남은 체류 기간 동안 쇼핑이나 관광 등 추가적인 활동을 가능하게 한다. 이는 환자의 신체적·심리적 만족도를 극대화하며, 자국으로 돌아간 후 긍정적인 효과(입소문)를 통해 또 다른 환자 유치로 이어지는 선순환이 이루어질 수 있도록 한다.

## 한계점: 임상 프로토콜의 표준화 부족

위의 해법이 성공적으로 안착하기 위해서는 수술 종류 및 환자 상태별로 표준화된 임상 진료지침(CP)이 필수적이다. 그러나 현재 미용과 성형 사후관리에 특화된 한의약 치료의 객관적인 통계 데이터나 국가적 차원에서 규격화된 프로토콜은 아직 부족한 상황이다. 더불어, '어혈', '기혈 순환'과 같은 한의학 고유의 병리 및 치료 원리를 외국인 환자가 직관적으로 이해하기 어렵다는 장벽이 존재한다. 이는 외국인 환자에게 신뢰를 형성하는 데 있어 초기 진입 장벽으로 작용할 수 있다.

## Ⅳ. 결론

결론적으로, 한의약이 지닌 고유의 강점인 전인적 치료와 회복 능력을 바탕으로 K-뷰티 의료 시장의 핵심 사각지대인 사후관리 영역에 진입하는 편승 전략은 현재 한의학이 할 수 있는 최선의 접근법이라고 생각한다. 의원급 한·양방 교차고용 활성화와 K-Recovery 패키지 도입을 통한 사후관리 모델 구축은 수술 후유증으로 고통받는 외국인 환자의 종합적인 의료 서비스 만족도를 크게 향상시킬 것이다.

궁극적으로 미용 수요에 편승한 이러한 전략은 외국인 환자들에게 한의약의 우수한 임상적 효과를 직접 체험하게 함으로써 세계 시장에서 한의약에 대한 긍정적인 인식을 확산시킬 수 있다. 이는 제5차 한의약 육성발전 종합계획이 목표로 하는 '세계인과 소통하는 K-Medicine' 실현과 한의약의 성공적인 글로벌 진출을 하는 밑거름이 될 수 있을 것이라고 믿어 의심치 않는다.

## Ⅴ. 참고문헌


1) 보건복지부. (2026). 2025년 외국인 환자 유치 200만 돌파: 아시아 의료관광 '중심국가' 도약 (보도자료). 세종: 보건복지부 보건산업정책국.

2) 조세특례제한법, 법률 제21223호, 제107조의3 (2025). https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000120954

3) 노정동. (2026, 7월 31일). 외국인 미용성형 부가세 환급 연장법, 국회 소위 회부. 한국경제. https://www.hankyung.com/article/2026073169026

4) 보건복지부. (2025, 1월 21일). 외국인환자를 위한 메디컬코리아지원센터 서울역 내 이전 개소 (보도자료). https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&act=view&list_no=1484406

5) 주혜진. (2014, 2월 20). 성형수술 후 멍·부종 걱정된다면?. 헬스경향. https://www.k-health.com/news/articleView.html?idxno=7050

6) 보건복지부. (2025, 6월 16). 의·한 협진 5단계 시범사업 실시 [보도자료]. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&act=view&list_no=1486295

7) 채혜선. (2026, 7월 23). [단독] "침 안놔요, 레이저 쏩니다"…미용시장 침공한 한의원. 중앙일보. https://www.joongang.co.kr/article/25447724

8) Kim, J. H., Lee, C. K., Lee, E. Y., Cho, M. R., Lee, Y. S., & Lee, J. S. (2021). Effects of Dangguixu-san in patients with acute lateral ankle sprain: a randomized controlled trial. Trials, 22(1), 184. https://doi.org/10.1186/s13063-021-05135-6

9) 권나현, 김찬영, 신예지, 서산, 송정화, 백용현, 우현수 and 박동석. (2009). 미소안면침 시술 후 안면 주름 측정값 변화에 대한 임상적 고찰. Journal of Acupuncture Research, 26(6), 133-140.

10) 문현우, 구승혁, 김성현, 황보승윤, 최현진, 안상준, 이종현 and 박현석. (2023). 교통사고로 인한 추벽증후군에 대한 한의학적 치료의 효과: 증례보고. 한방재활의학과학회지, 33(1), 87-96.